

L'équilibre vital : Homéostasie et Allostasie



Homéostasie

Maintien de la stabilité.
Régulation du milieu intérieur
(température, pH, glycémie).



Allostasie

Capacité d'adaptation.
Maintien de l'homéostasie
dans un contexte changeant.

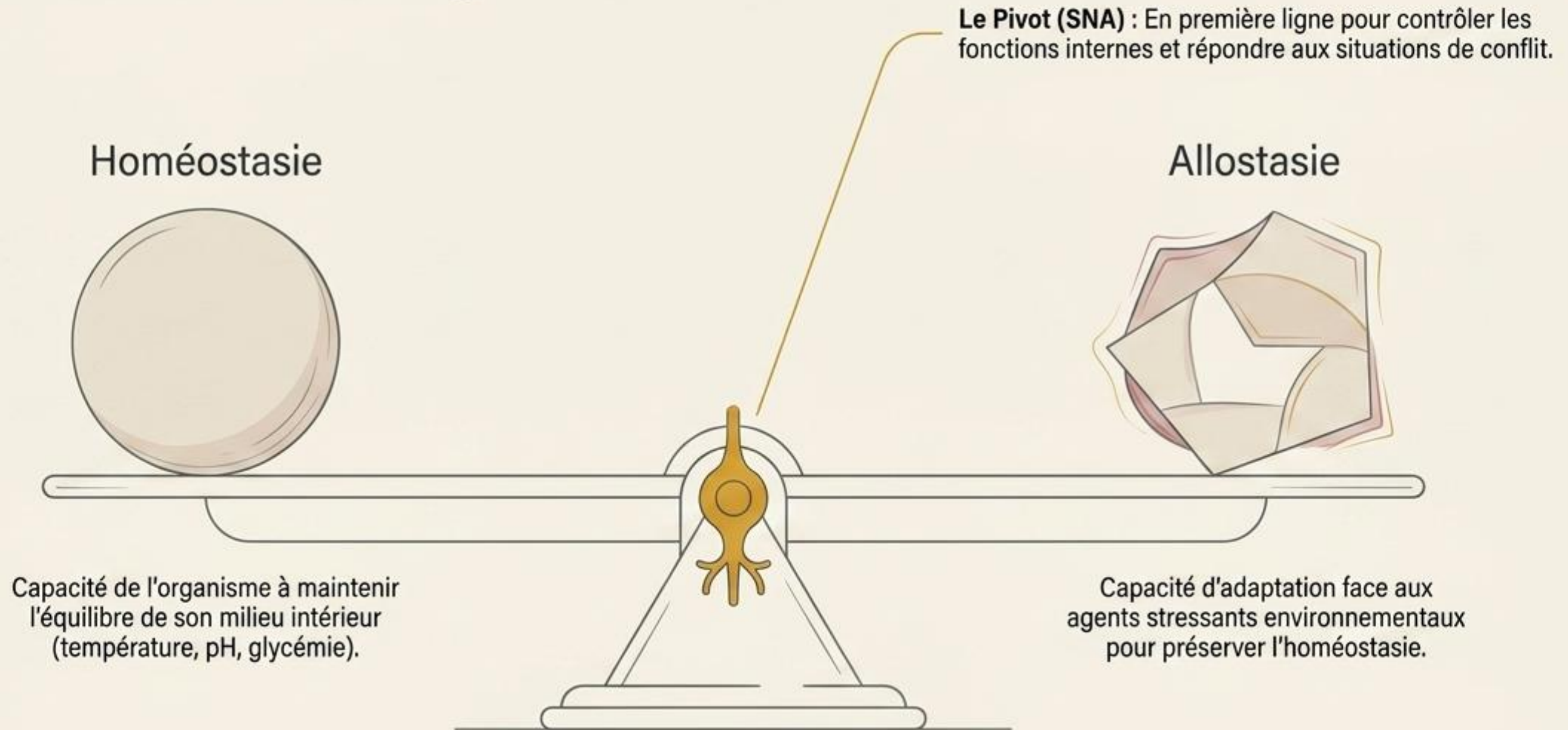


Stress

Réaction de préservation.
Ensemble des réactions face
à une menace pour limiter
l'écart homéostatique.

Rôle clé du SNA :
Le Système Nerveux
Autonome est en première
ligne pour préserver
l'équilibre interne.

Le Mécanisme de Stress : Stabilité dans le changement



Le stress est un phénomène protecteur fondamental. À court terme, il protège. À long terme, il a un coût énergétique.

Dualité du stress : Distress vs. Eustress

Distress (Négatif)



- **Émotions** : Peur, colère, insécurité, échec.
- **Réponse neuroendocrinienne** : Dominance du Cortisol.
- **Impact** : Fragilisation des systèmes nerveux, hormonal et immunitaire. Évolution pathogène.

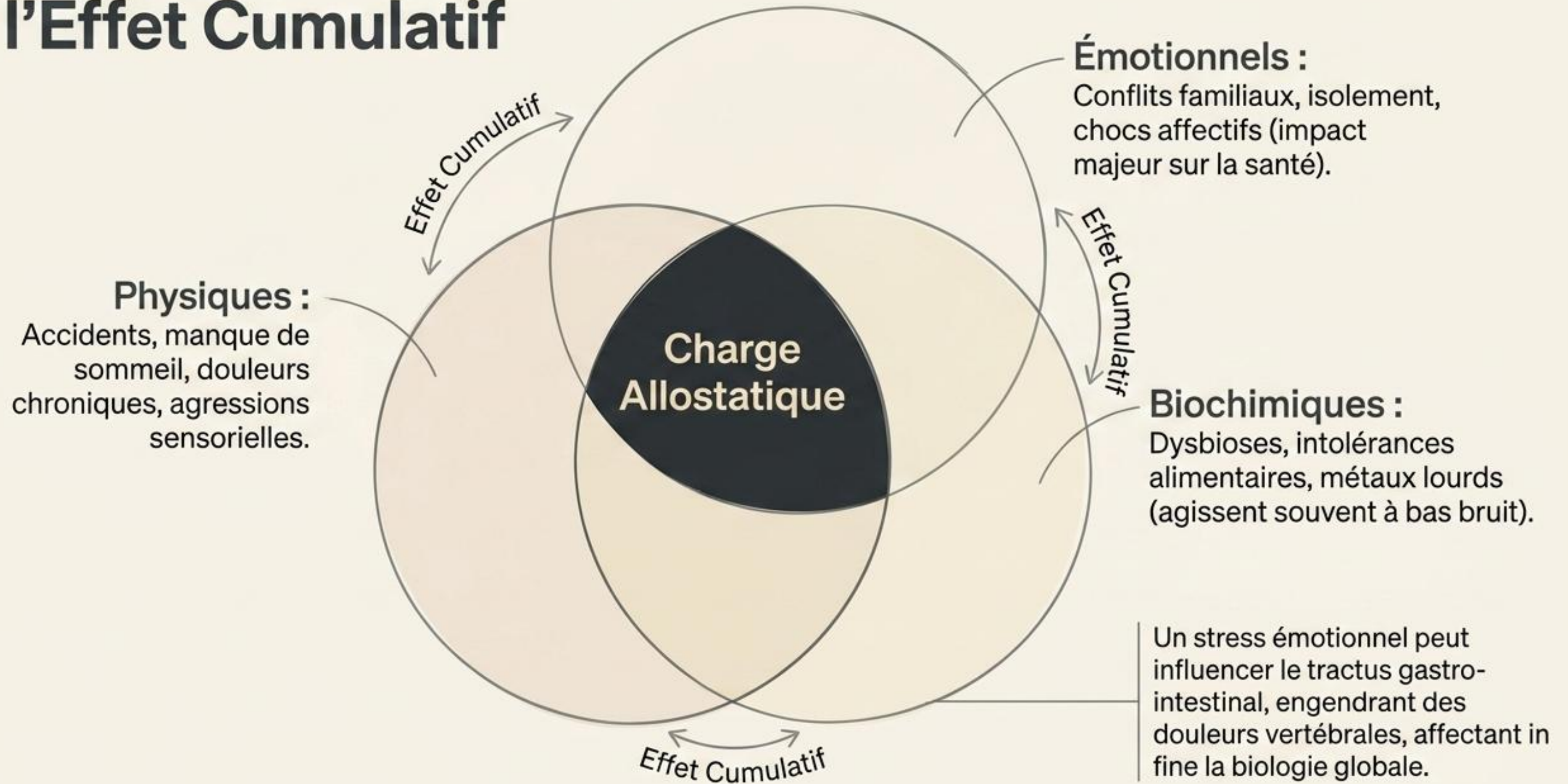
Eustress (Positif)



- **Émotions** : Joie, amour, enthousiasme, sécurité.
- **Réponse neuroendocrinienne** : Activation neuromédatrice (Adrénaline).
- **Impact** : Réponse adaptative favorable, stimulante et nécessaire à court terme.

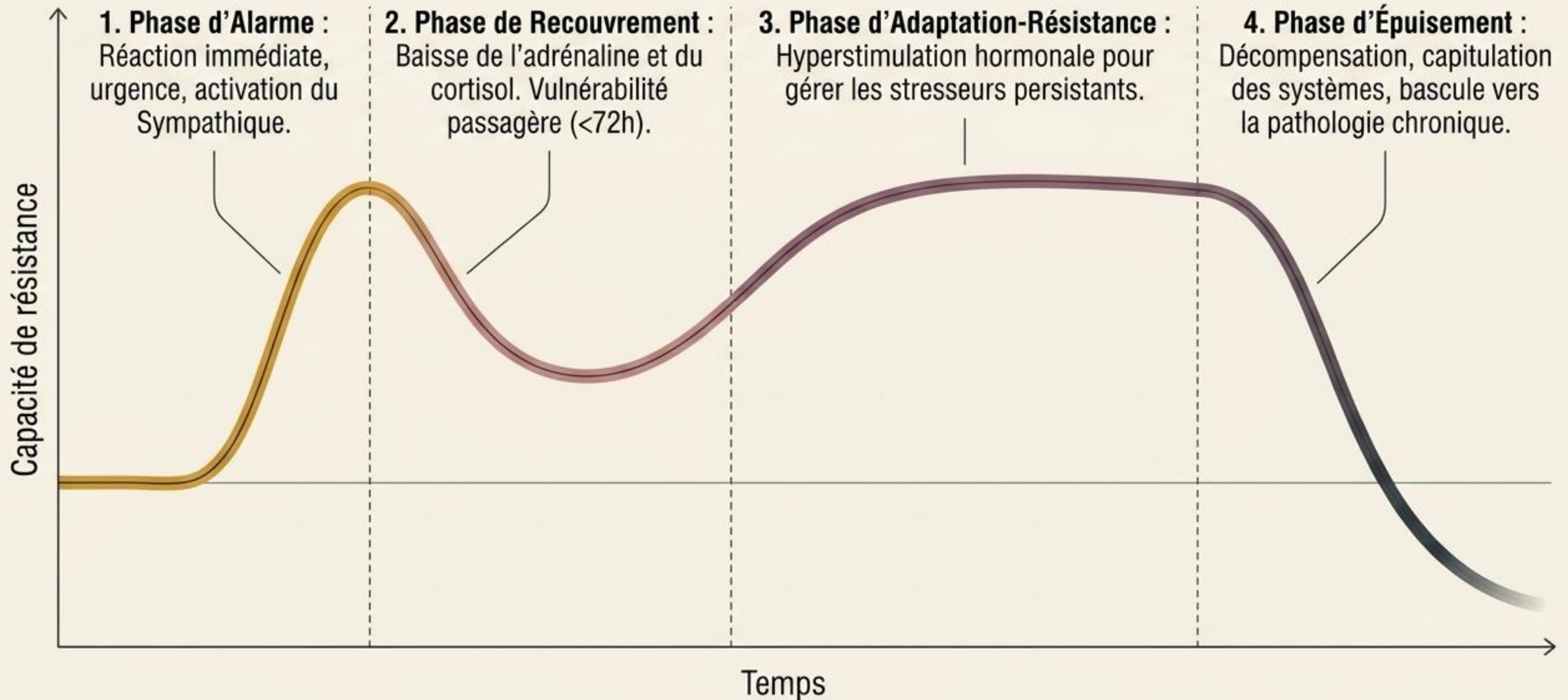
Différenciation de la polarité du stress et de sa réponse hormonale.

La Trilogie des Stresseurs et l'Effet Cumulatif



Le Syndrome Général d'Adaptation (SGA)

Modèle développé
par Hans Selye.

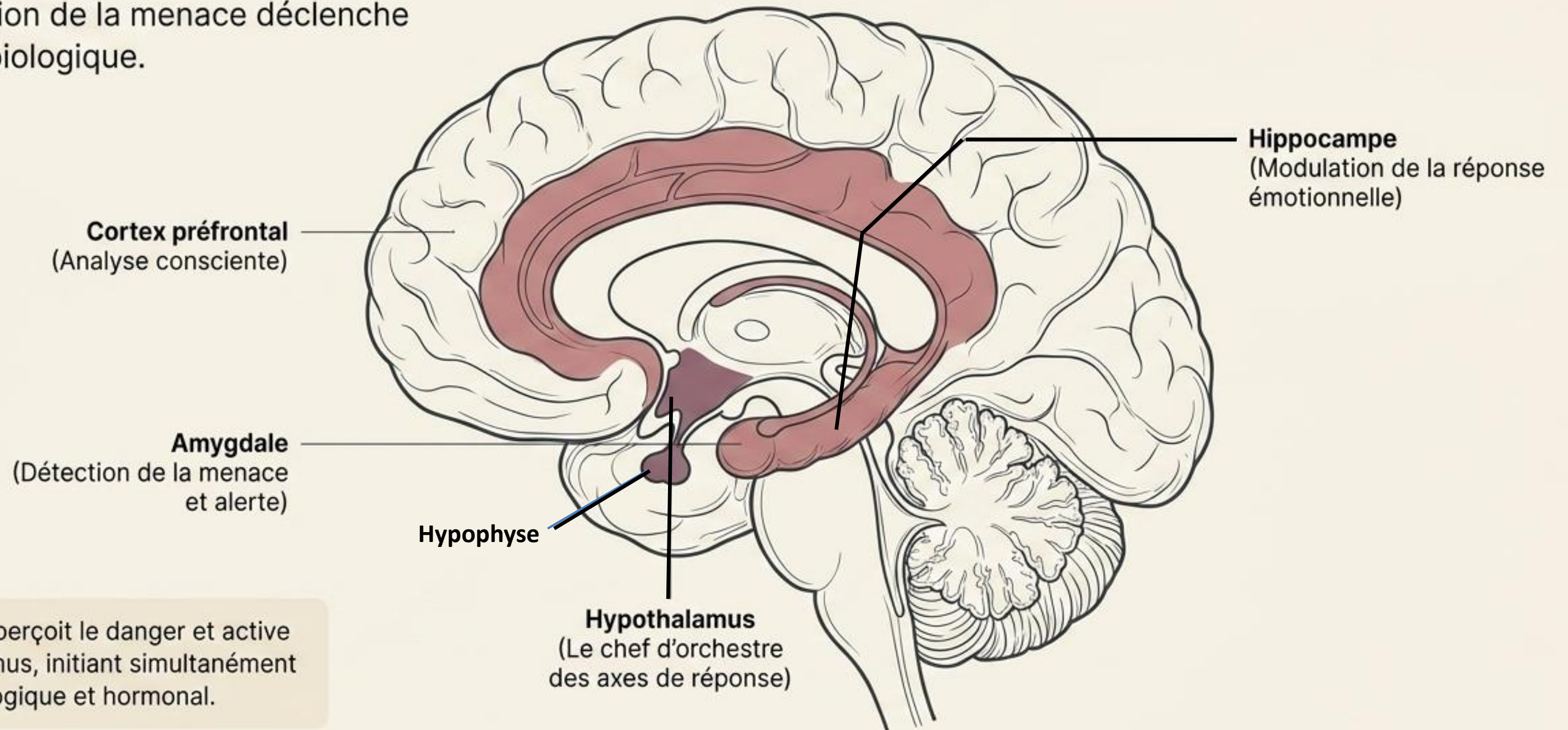


Phase d'alarme : Matrice de réponse physiologique

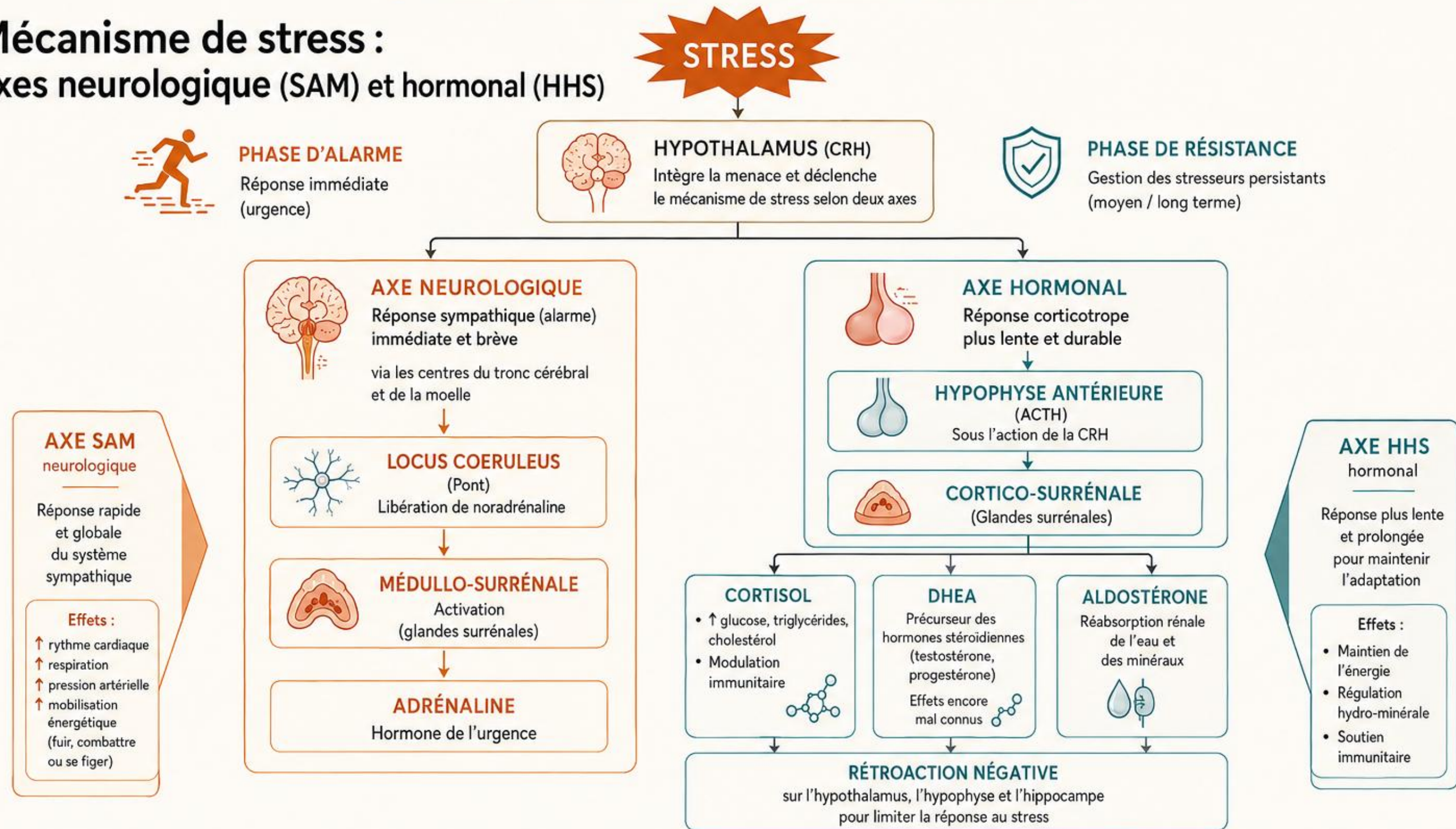
<u>Axe SAM (Neurologique)</u>	<u>Axe HHS (Hormonal)</u>
- Vitesse : Immédiate (Urgence) - Origine : Hypothalamus → Locus Coeruleus (Tronc cérébral) - Hormone clé : Adrénaline / Noradrénaline - Effets physiologiques : Accélération cardiaque, augmentation pression artérielle, apport sanguin aux muscles striés (fuir ou combattre). Mise en veille de la digestion.	- Vitesse : Secondaire (si le stress persiste) - Origine : Hypothalamus (CRH) → Antéhypophyse (ACTH) - Hormones clés : Cortisol, Aldostérone, DHEA - Effets physiologiques : Disponibilité du glucose/cholestérol, réabsorption rénale, modulation immunitaire.

Le point de bascule : Cerveau limbique et Hypothalamus

L'interprétation de la menace déclenche la cascade biologique.



Mécanisme de stress : axes neurologique (SAM) et hormonal (HHS)



PHASE D'ALARME

Réponse immédiate et brève via l'axe SAM (sympathique).
Si le stressor persiste, l'hypothalamus active l'axe HHS (hormonal) pour soutenir l'adaptation.



PHASE DE RÉSISTANCE

L'axe HHS prend le relais pour gérer les stressors persistants.
Si la charge allostatique devient trop importante, les systèmes s'épuisent et évoluent vers la phase d'épuisement.

- Axe neurologique (SAM) – réponse rapide
- Axe hormonal (HHS) – réponse lente et durable
- Rétroaction négative
- Influences de modulation (limbique / cortex)

Phase 2 : Recouvrement et Vulnérabilité

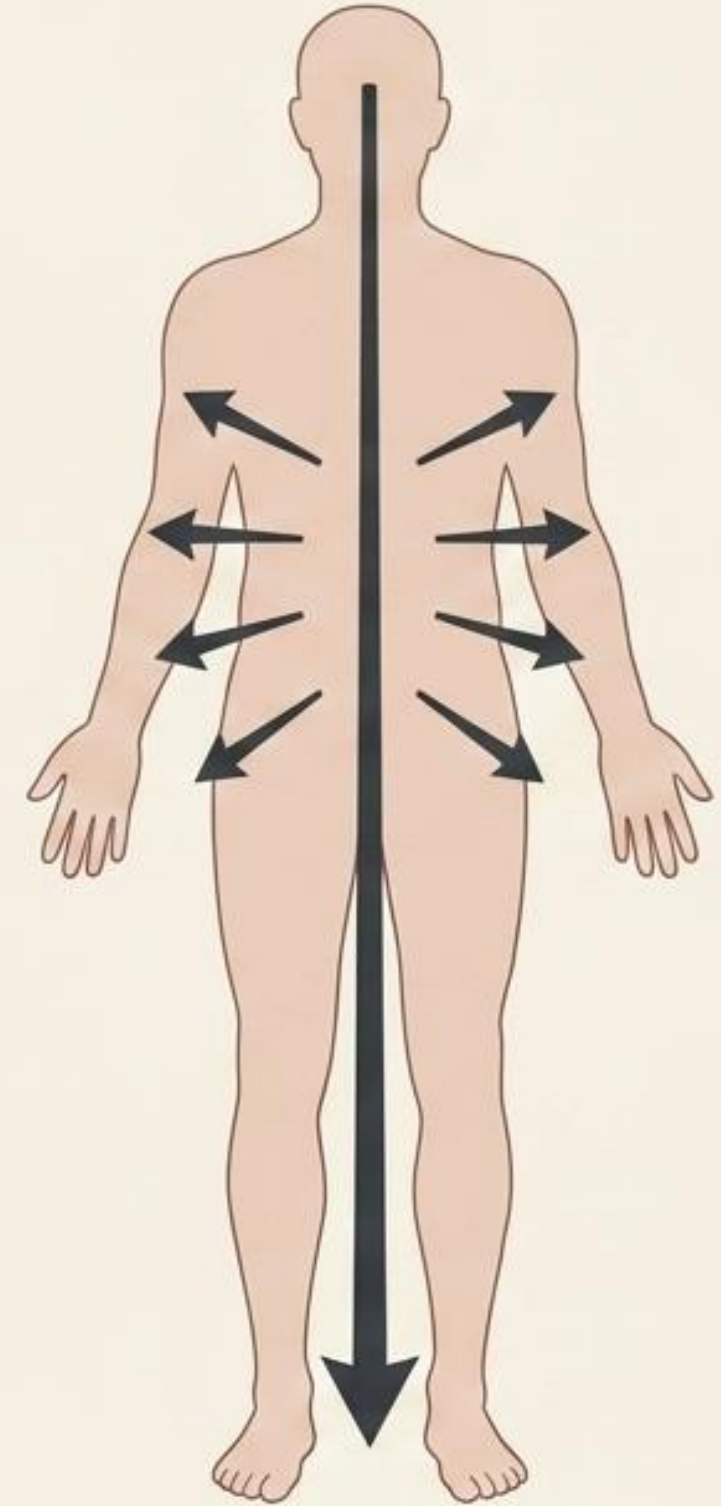
Mots-clés : Fatigue, récupération, vulnérabilité passagère (max 72h).

Physiologie : Baisse du cortisol et de l'adrénaline.
Recrudescence des douleurs, évacuation émonctorielle accrue.

Lien Thérapeutique (Loi de Hering) :

En réflexothérapie, cette phase explique les réactions post-séance. La guérison s'opère :

1. Du haut vers le bas
2. Du dedans vers le dehors
3. Du chronique vers l'aigu



Période de récupération physiologique et direction des symptômes salutaires.

Phase 3 : Adaptation-Résistance

Mots-clés : Organisation des défenses, chronicité, stressseurs persistants.

Hyperstimulation (Le soutien)



Surrénales : Excès de Cortisol (hypertension, ostéoporose).



Pancréas : Hyperinsulinémie (résistance cellulaire).



Thyroïde : Excès T3/T4 (nervosité, tachycardie).

Hypostimulation (Le basculement)



Évolution vers hypothyroïdie, hypoglycémie, et hypocorticisme (étourdissements orthostatiques).

Statut Pathologique :
Apparition d'allodynie (douleur exacerbée).
L'intégrité anatomique commence à céder.

Le coût métabolique de l'adaptation prolongée.

L'Épuisement : Du dysfonctionnement à la chronicité

Perte d'intégrité anatomique

	Fonctionnel (Réversible)	Chronique (Irréversible)
Système Immunitaire	Allergies légères, intolérances alimentaires.	Maladies infectieuses graves, maladies auto-immunes.
Système Digestif	Hypersensibilité, troubles du transit, dysbiose, côlon irritable.	Ulcération gastroduodénale sévère.
Système Nerveux / Limbique	Peur, anxiété, allodynie (douleur articulaire anormale).	Dépression majeure, atrophie de l'hippocampe, Alzheimer, maladies neurodégénératives.

« Nous sommes malades parce que nous perdons la santé, et non l'inverse. »

L'échec des mécanismes d'adaptation face à la charge allostatique est l'antichambre de la pathologie.

Conclusion Clinique : Les thérapies fonctionnelles et intégratives (ROP) n'ont pas pour unique but de supprimer un symptôme, mais de soutenir les organes émonctoriels et de restaurer la vitalité nécessaire pour que l'organisme puisse combattre la maladie.

